CHUYÊN LUẬN DƯỢC LÂM SÀNG: PAPAVERIN

Papaverine hydroclorid • Mã ATC: A03AD01 • Chống co thắt cơ trơn hướng cơ

1. THÔNG TIN CHUNG & DẠNG BÀO CHẾ

• Tên hoạt chất: Papaverin (dưới dạng muối Papaverine hydroclorid - Papaverine HCl).

• Biệt dược phổ biến: Papaverin 40mg, Pavabid, Papaverin Vinphaco 40mg/2ml, Papaverine 100mg.

• Dạng bào chế: Viên nén 40 mg, 100 mg; Dung dịch thuốc tiêm: 40 mg/2 ml, 50 mg/1 ml, 100 mg/2 ml (tiêm bắp, tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch chậm).

2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG & ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ ĐẶC THÙ

• Cơ chế hướng cơ trực tiếp: Papaverin là dẫn xuất benzylisoquinolin alkaloid thuốc phiện nhưng KHÔNG có tác dụng giảm đau trung ương kiểu opioid và không gây nghiện. Thuốc ức chế men phosphodiesterase (PDE) không chọn lọc, làm tăng nồng độ cAMP nội bào, ức chế calci nội bào gây giãn trực tiếp sợi cơ trơn.

• Phổ tác dụng rộng: Gây giãn cơ trơn mạch máu (mạch não, mạch vành, mạch ngoại vi), cơ trơn đường tiêu hóa, đường mật, đường tiết niệu (niệu quản, bàng quang) và cơ tử cung.

• Khác biệt với nhóm kháng cholinergic (Atropin, Hyoscine): Papaverin không chẹn thụ thể muscarinic nên KHÔNG gây khô miệng, bí tiểu nặng, nhìn mờ hay liệt ruột.

3. CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ CHÍNH

1. Chống co thắt đường tiêu hóa & đường mật: Cơn đau quặn gan, cơn đau quặn mật do sỏi, viêm đường mật, viêm túi mật; co thắt dạ dày - ruột, hội chứng ruột kích thích (IBS).

2. Chống co thắt đường tiết niệu: Cơn đau quặn thận cấp tính, sỏi niệu quản, đau quặn bàng quang, co thắt niệu đạo khi làm thủ thuật can thiệp sỏi.

3. Co thắt mạch máu não và ngoại vi: Cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA), đau nửa đầu migraine, co thắt động mạch ngoại vi (hội chứng Raynaud, viêm tắc động mạch).

4. Sản phụ khoa: Đau bụng kinh nguyên phát (thống kinh co thắt tử cung).

5. Nam học chuyên khoa: Tiêm trực tiếp vào thể hang (Intracavernosal) chẩn đoán và điều trị rối loạn cương dương (ED).

4. LIỀU DÙNG & ĐƯỜNG DÙNG CHI TIẾT

• Người lớn (Đường uống): 40 mg – 100 mg mỗi lần, ngày 2 – 3 lần (tối đa 300 mg/ngày). Uống cùng hoặc sau bữa ăn.

• Tiêm bắp (IM) / Tiêm dưới da: 30 mg – 120 mg mỗi 3 – 4 giờ khi đau cấp tính.

• Tiêm tĩnh mạch chậm (IV): 30 mg – 65 mg. BẮT BUỘC TIÊM CỰC KỲ CHẬM TRONG 1 – 2 PHÚT (hoặc pha loãng với 10 - 20 mL NaCl 0.9% hoặc Glucose 5%).

• Trẻ em: 1.5 – 2 mg/kg/ngày chia 3 – 4 lần (uống); đường tiêm chỉ dùng trong cấp cứu hồi sức nhi khoa.

5. HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH LIỀU THEO CHỨC NĂNG THẬN (CrCl)

Mức thanh thải (CrCl)	Liều dùng khuyến cáo	Ghi chú lâm sàng
CrCl >= 50 mL/phút	Không cần chỉnh liều	Dùng liều tiêu chuẩn thông thường
CrCl 10 - 50 mL/phút	Thận trọng, dùng liều tối thiểu	Theo dõi huyết áp và nhịp tim
CrCl < 10 mL/phút	Giảm 25% - 50% liều	Nguy cơ tích lũy chất chuyển hóa
Lọc máu ngắt quãng (HD)	Không cần bổ sung sau lọc	Gắn protein huyết tương cao (~90%), không qua màng lọc

6. CẢNH BÁO NGUY HIỂM & ĐIỂM NHẤN DƯỢC LÂM SÀNG (CLINICAL PEARLS)

• NGUY HIỂM KHI TIÊM TĨNH MẠCH NHANH: Tiêm IV nhanh có thể ức chế tức thì hệ thống dẫn truyền cơ tim, gây block nhĩ thất hoàn toàn, ngoại tâm thu thất, rung thất, ngừng thở đột ngột và trụy tim mạch tử vong. Luôn tiêm rất chậm trong ít nhất 1 - 2 phút kèm theo dõi mạch, huyết áp.

• ĐỘC TÍNH TRÊN GAN DO DỊ ỨNG: Papaverin có thể gây viêm gan nhiễm độc, vàng da ứ mật, tăng men gan (AST/ALT/Phosphatase kiềm) do cơ chế quá mẫn. Cần xét nghiệm men gan định kỳ nếu điều trị kéo dài > 2 tuần và ngừng thuốc ngay nếu có dấu hiệu tổn thương gan.

• TƯƠNG TÁC ĐỐI KHÁNG ĐẶC BIỆT VỚI LEVODOPA: Papaverin làm mất hoàn toàn tác dụng điều trị Parkinson của Levodopa do đối

kháng thụ thể dopamine tại thể vân não. TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG cho bệnh nhân Parkinson đang điều trị Levodopa.

• NGUY CƠ CƯƠNG ĐAU DƯƠNG VẬT KÉO DÀI (PRIAPISM): Khi tiêm thể hang điều trị rối loạn cương, nếu cương cứng kéo dài trên 4 giờ, bắt buộc phải xử trí cấp cứu nam khoa ngay (hút máu thể hang và tiêm Phenylephrine) để tránh thiếu máu hoại tử và xơ hóa thể hang vĩnh viễn.